



НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(НСЗУ)

просп. Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073, тел.: (044) 426-67-77, (044) 290-06-91

E-mail: info@nszu.gov.ua, сайт: www.nszu.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 42032422

від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

Надавачам медичних послуг
за списком

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виявлені в ході автоматичного моніторингу порушення умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій у частині внесення недостовірних або неповних даних, на підставі яких були сформовані звіти про медичні послуги

Національна служба здоров'я України (далі – НСЗУ), як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, з метою належного виконання вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) та Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 (далі – Положення), повідомляє.

Статтею 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з підпунктами 4, 5, 5¹ та 13 пункту 4 Положення НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань:

укладає, змінює та припиняє договори про медичне обслуговування населення та договори про реімбурсацію;

здійснює заходи, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій;

проводить моніторинг виконання умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію у порядку, встановленому законодавством;

аналізує звітність надавачів медичних послуг щодо переліку та обсягу наданих медичних послуг за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Частиною першою статті 8 Закону визначено, що договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладається між Уповноваженим органом (НСЗУ) та закладом охорони здоров'я незалежно від форми власності чи фізичною особою – підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що



відповідають встановленим Кабінетом Міністрів України вимогам до надавача медичних послуг за програмою медичних гарантій, та має відповідати умовам закупівлі, специфікаціям до медичних послуг, а також враховувати визначений у програмі медичних гарантій обсяг забезпечення медичними послугами відповідно до потреб у межах кожного госпітального округу.

Відповідно до пункту 5 договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – Договір), укладеного між НСЗУ та вами, моніторинг – комплекс заходів, які здійснюються замовником, щодо збору та аналізу інформації стосовно виконання надавачем умов Договору.

Згідно з положеннями пункту 5¹ Договору, автоматичний моніторинг – комплекс постійних автоматизованих заходів, заснованих на ризик-орієнтованому підході, які здійснюються з використанням інформаційно-комунікаційних систем, зокрема інформаційної системи замовника, для отримання інформації, необхідної для вирішення питання про проведення фактичного моніторингу, планування фактичного моніторингу, верифікації даних, що містяться в електронній системі охорони здоров'я (далі - Система), та застосування заходів, передбачених цим договором.

Відповідно до підпунктів 2, 3 та 13 пункту 19 Договору, надавач медичних послуг зобов'язується:

відповідати вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства, умовам закупівлі;

дотримуватися вимог законодавства, зокрема порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі примірних, галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, а також забезпечувати дотримання підрядниками зазначених вимог;

своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації.

Вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп (далі - ДСГ) для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1503 (далі – Порядок) встановлено Додатком 1 до Порядку. При цьому, ваговий коефіцієнт ДСГ І02 «Мікрovasкулярні пересадки тканин чи шкіри, крім рук» становить 6,346 і ця ДСГ входить у перелік 10 ДСГ із найвищими ваговими коефіцієнтами за пакетом медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» (далі - Пакет 3).

Високий розмір вагового коефіцієнта ДСГ І02 зумовлений, серед іншого, складністю ведення таких пацієнтів та пролонгованим терміном госпіталізації (середня тривалість госпіталізації за даними ЕСОЗ у 2025 році – 12 діб). При цьому, у результаті аналізу пролікованих випадків за цією ДСГ встановлено, що значна частина пролікованих випадків із результатом лікування «Виписаний з покращенням» має тривалість госпіталізації значно нижче середньої:

- 5 діб та менше - 2516 (38,76%);

- 1-2 доби – 21% (1359) випадків, з яких 855 з відсутніми додатковими діагнозами.

Короткотривалість госпіталізації та відсутність додаткових діагнозів опосередковано свідчать про відносно легкий стан пацієнтів, оскільки саме діагнози зазначені в електронних медичних записах (далі - ЕМЗ) впливають на складність пролікованого випадку.

Більш детальний аналіз основного діагнозу та проведених інтервенцій засвідчив, що надавачі в ЕМЗ зазначають декілька інтервенцій, які є складовими однієї операції або не виконуються при даному діагнозі. Зокрема такі інтервенції як:

- 90675-00 Інше відновлення шкіри та підшкірної клітковини;
- 45200-00 Місцевий шкірний клопот ділянки іншої локалізації.

Необґрунтоване зазначення вищенаведених інтервенцій призводить до віднесення ЕМЗ до ДСГ І02 з більш високим ваговим коефіцієнтом.

Інформуємо, що НСЗУ проведено автоматичний моніторинг за пакетами медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» в частині повноти та достовірності ЕМЗ віднесених до ДСГ І02 «Мікрovasкулярні пересадки тканин чи шкіри, крім рук».

За результатом автоматичного моніторингу внесених в ЕСОЗ ЕМЗ, які були віднесені до ДСГ І02, та включені до звітів про надані медичні послуги, були виявлені випадки, у яких тривалість надання послуги (госпіталізації) та діагнозу не відповідає внесений у цьому медичному записі інформації про проведені процедури та/або втручання, зокрема за інтервенціями «90675-00, Інше відновлення шкіри та підшкірної клітковини» та «45200-00, Місцевий шкірний клопот ділянки іншої локалізації».

За результатами автоматичного моніторингу, проведено оновлення віднесення ЕМЗ до пакетів медичних послуг та ДСГ, без врахування відповідних інтервенцій.

Додаток: перелік медичних записів з результатами додаткового визначення ДСГ/переведення в терапевтичну групу за результатами автоматичного моніторингу, у форматі Excel.

Голова

Наталія ГУСАК